МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

[наименование образовательной организации]
[факультет / институт]
Кафедра [название кафедры]

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Социальная работа за рубежом»

на тему «Социальная работа в США:
становление, организация и современная практика»

Выполнил: студент(ка) ____ группы
[фамилия, имя, отчество]

Проверил: [должность]
[фамилия, имя, отчество]

Ростов-на-Дону — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ИСТОРИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В США 6

1.1 Становление социальной работы как профессии 6

1.2 Организация системы социальных услуг 9

1.3 Профессиональное образование, аккредитация и лицензирование . . 12

2 ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И ЭТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 15

2.1 Ведущие теоретические подходы 15

2.2 Технология работы с клиентом и сообществом 18

2.3 Этические принципы и принятие решений 21

3 ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАКТИКИ . 24

3.1 Социальная работа с детьми, семьями и в школе 24

3.2 Медицинская, клиническая и кризисная социальная работа 25

3.3 Жилищная поддержка, старение, инвалидность и защита уязвимых групп 27

3.4 Занятость, цифровизация и перспективы развития 30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 36

ПРИЛОЖЕНИЕ А 38

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 40

ПРИЛОЖЕНИЕ В 42

ВВЕДЕНИЕ

Социальная работа в США представляет собой развитую профессиональную систему, объединяющую непосредственную помощь людям, развитие сообществ, формирование социальной политики и защиту прав уязвимых групп. Ее особенность заключается в одновременном внимании к личной ситуации клиента и к условиям среды, которые порождают или усиливают трудности. Поэтому американская модель не сводится к выдаче пособий или к психологическому консультированию. Она включает координацию медицинских, образовательных, жилищных, правовых и социальных ресурсов, а также оценку результатов вмешательства.

Актуальность темы определяется ростом сложных социальных проблем, с которыми работают специалисты США. Бездомность, неблагополучие в семьях, психические расстройства, зависимости, старение населения, миграция и неравенство доступа к услугам требуют межсекторного взаимодействия. Пандемия COVID-19 дополнительно ускорила распространение дистанционных сервисов и обозначила проблему цифрового неравенства. Одновременно повысились требования к культурной компетентности, травма-информированной практике, доказательности решений и профессиональному самосохранению работников.

Изучение американского опыта имеет не только описательное, но и аналитическое значение. Оно позволяет выявить сильные стороны компетентностной модели образования, лицензирования, супервизии и этической регуляции, а также увидеть ограничения децентрализованной системы. Перенос отдельных подходов в иной национальный контекст требует критической оценки, поскольку институты социальной работы связаны с законодательством, финансированием, структурой медицинского страхования и традициями гражданского общества конкретной страны.

Целью работы является комплексный анализ становления, организации, методов и современных направлений социальной работы в США. Объектом исследования выступает социальная работа как профессиональная и институциональная система. Предметом исследования являются исторические основания, организационные формы, образовательные

стандарты, методы практики и этические принципы американской социальной работы.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

— рассмотреть основные этапы профессионализации социальной работы в США
— охарактеризовать распределение полномочий между федеральным уровнем, штатами, местными органами и некоммерческими организациями
— проанализировать систему профессионального образования, аккредитации, лицензирования и супервизии
— раскрыть содержание ведущих теоретических подходов и этапов работы с клиентом
— определить значение Кодекса этики Национальной ассоциации социальных работников
— исследовать основные сферы практики, кадровые показатели и современные вызовы
— сформулировать выводы о возможностях и границах использования американского опыта

Методологическую основу составили историко-генетический, системный, сравнительно-правовой и структурно-функциональный подходы. В работе использованы анализ научной и учебной литературы, содержательный анализ профессиональных стандартов, обобщение официальной статистики, а также сравнение микро-, мезо- и макроуровней практики. Статистические показатели приведены за годы, указанные в соответствующих официальных отчетах, и не рассматриваются как одномоментная характеристика всех штатов.

Информационную базу образуют учебники М. Пейна, Д. Хепворта и соавторов, Ч. Застроу и С. Хессенауэр, исследования профессиональной этики Ф. Римера, исторические работы Дж. Аддамс и М. Ричмонд, статьи М. Райша, Б. Рут и Дж. Маршалла. Использованы документы CSWE, NASW, ASWB, Бюро трудовой статистики США, ACF, SAMHSA и HUD. Сочетание монографий, журнальных статей, нормативных документов и официальных интернет-источников позволяет рассматривать профессию с теоретических и прикладных позиций.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. В первой главе рассматриваются история и институциональная организация, во второй раскрываются теория, технология и этика практики, в третьей анализируются отдельные сферы услуг и современные тенденции. Приложения содержат глоссарий, обобщенный алгоритм помощи и сопоставление уровней профессиональной подготовки.

1 ИСТОРИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В США

1.1 Становление социальной работы как профессии

Истоки американской социальной работы связаны с общинной взаимопомощью, религиозной благотворительностью и местными институтами призрения. В колониальный период значительное влияние оказали английские законы о бедных, в соответствии с которыми ответственность за поддержку нуждающихся возлагалась преимущественно на местную общину. Помощь носила локальный и разнородный характер, а ее получение нередко сопровождалось проверкой имущественного положения и моральной оценки образа жизни. Такое наследие надолго сохранило противоречие между поддержкой человека и социальным контролем.

Во второй половине XIX века индустриализация, урбанизация и массовая иммиграция изменили масштаб социальных проблем. Концентрация бедности в городах, тяжелые условия труда, перенаселенность и слабость коммунальной инфраструктуры сделали прежние формы благотворительности недостаточными. Возникла потребность в систематической регистрации нуждающихся, координации частных агентств и изучении причин семейного неблагополучия. Ответом стали движение обществ организации благотворительности и движение поселений.

Первое американское Charity Organization Society было создано в Буффало в 1877 году. Сторонники этой модели стремились упорядочить распределение помощи, исключить дублирование и проводить индивидуальное обследование семей. Метод дружественного посещения соединял материальную поддержку с наблюдением и наставлением. Историческая оценка данной модели неоднозначна. Она способствовала развитию кейсовой работы и профессиональной документации, но одновременно могла воспроизводить морализаторство и деление бедных на достойных и недостойных помощи [10; 15].

Иное направление представляли поселения, наиболее известным из которых стал Халл-хаус, открытый Джейн Аддамс и Эллен Гейтс Старр в Чикаго в 1889 году. Поселенцы жили в иммигрантских районах, организовывали образование, досуг, уход за детьми, юридическую

поддержку и общественные исследования. Центральное место занимало не исправление отдельной семьи, а изменение среды и расширение возможностей сообщества. Джейн Аддамс связывала повседневную помощь с трудовым законодательством, защитой детей, миротворчеством и участием граждан в общественной жизни [1].

Два направления сформировали устойчивое профессиональное напряжение между индивидуальной адаптацией и социальными преобразованиями. В дальнейшем оно проявлялось в спорах о приоритете клинической практики, общественной организации и политической адвокации. М. Райш показывает, что эта история не представляет собой линейное движение от благотворительности к совершенной профессии. В ней постоянно взаимодействовали стремление к социальной справедливости, поиск профессионального статуса, зависимость от финансирования и влияние господствующих представлений о бедности [10].

Важным этапом стало появление систематической подготовки. Летние курсы Нью-Йоркской благотворительной школы были организованы в 1898 году, а впоследствии учебные программы получили развитие в университетах. Публикация книги Мэри Ричмонд «Социальный диагноз» в 1917 году закрепила представление о последовательном исследовании случая. Ричмонд рассматривала социальные свидетельства, семейную историю и факторы среды как основание для индивидуального плана помощи [11]. Ее подход способствовал превращению интуитивной благотворительности в описываемую и обучаемую профессиональную деятельность.

В первой половине XX века расширились медицинская, психиатрическая и школьная социальная работа. Опыт мировых войн усилил внимание к психическому здоровью и реабилитации. Великая депрессия выявила невозможность решения массовой безработицы исключительно частной благотворительностью. Закон о социальном обеспечении 1935 года создал важную федеральную основу пенсионного страхования, страхования от безработицы и ряда программ помощи. Социальные работники стали активнее участвовать в государственных службах и в реализации публичной политики.

После Второй мировой войны развивались программы охраны психического здоровья, общественного здравоохранения и социального обеспечения. В 1952 году был образован Совет по образованию в области социальной работы, а в 1955 году несколько профессиональных объединений сформировали Национальную ассоциацию социальных работников. Эти процессы укрепили единые образовательные и этические стандарты. В 1960-е годы движение за гражданские права, программы борьбы с бедностью и расширение Medicare и Medicaid повысили значение адвокации и работы с неравенством. В конце XX века усилились рыночные механизмы, управляемая медицинская помощь, контрактирование услуг и требования измеримой результативности [10; 12].

Таблица 1 — Ключевые этапы развития социальной работы в США

Период	Основное событие	Значение для профессии
1877	Создание Charity Organization Society в Буффало	Развитие обследования случая и координации благотворительности
1889	Открытие Халл-хауса в Чикаго	Соединение помощи, развития сообщества и социальных реформ
1898	Систематические курсы подготовки в Нью-Йорке	Формирование профессионального образования
1917	Выход книги М. Ричмонд «Социальный диагноз»	Методологическое оформление индивидуальной социальной работы
1935	Принятие Закона о социальном обеспечении	Расширение федеральной ответственности и публичных служб
1952–1955	Создание CSWE и NASW	Консолидация образования, профессиональной идентичности и этики

Таблица 1 — Ключевые этапы развития социальной работы в США

Период	Основное событие	Значение для профессии
1960-е	Программы социальных реформ и развитие общественного здравоохранения	Усиление адвокации и межсекторной практики
Конец XX — начало XXI века	Развитие лицензирования, доказательной и цифровой практики	Повышение требований к качеству, подотчетности и компетентности

Таким образом, профессионализация происходила через взаимодействие частной благотворительности, университетского образования, государственной политики и общественных движений. Устойчивым результатом стало двойное измерение социальной работы. Специалист поддерживает конкретного человека и одновременно анализирует институциональные барьеры, которые ограничивают его благополучие. Игнорирование любого измерения делает понимание американской модели неполным.

1.2 Организация системы социальных услуг

Система социальных услуг США децентрализована и включает федеральные агентства, правительства штатов, округа и муниципалитеты, некоммерческие организации, частные поставщики, медицинские сети, школы и благотворительные фонды. Единого министерства, которое управляло бы всеми направлениями социальной работы, не существует. Отдельные программы концентрируются в Министерстве здравоохранения и социальных служб, Министерстве жилищного строительства и городского развития, Министерстве труда, Министерстве по делам ветеранов и других ведомствах. Поэтому профессиональная помощь и социальное обеспечение связаны, но не тождественны.

Федеральный уровень устанавливает базовые требования законодательства, формирует национальные программы, распределяет гранты и обеспечивает сбор статистики. Штаты определяют конкретные

правила реализации многих программ, лицензируют специалистов и организации, финансируют услуги и надзирают за соблюдением норм. Местные органы нередко осуществляют прием обращений, расследование рисков, кейс-менеджмент и закупку услуг. Некоммерческий сектор предоставляет значительную часть помощи на основании государственных контрактов, грантов и частных пожертвований.

Финансирование формируется из нескольких потоков. Налоговые поступления поддерживают государственные программы, Medicaid участвует в оплате определенных медицинских и социальных услуг, блочные и целевые гранты направляются штатам и сообществам. Страховые механизмы важны для клинической социальной работы, а филантропия позволяет некоммерческим организациям развивать инновационные проекты. Такое многообразие расширяет выбор форм помощи, но создает неоднородность правил, требует сложной отчетности и может порождать разрывы между программами.

Таблица 2 — Распределение функций в системе социальных услуг

Уровень или сектор	**Характерные функции**	**Основное ограничение**
Федеральный	Законодательство, финансирование национальных программ, стандарты, данные	Ограниченное непосредственное предоставление локальных услуг
Штат	Лицензирование, администрирование программ, надзор, софинансирование	Различия норм и доступности между юрисдикциями
Местный	Прием обращений, защита детей, координация помощи, контракты	Зависимость от бюджета и кадрового обеспечения
Некоммерческий	Социальные сервисы, адвокация, развитие сообщества, инновации	Нестабильность грантов и договорная нагрузка

Таблица 2 — Распределение функций в системе социальных услуг

Уровень или сектор	Характерные функции	Основное ограничение
Частный и медицинский	Клиническая практика, реабилитация, управляемая помощь	Зависимость от страхования и критериев оплаты

Важным механизмом координации выступает кейс-менеджмент. Специалист оценивает потребности, помогает сформулировать цели, связывает клиента с ресурсами, согласует действия поставщиков и отслеживает результат. Например, при выписке пациента из стационара может требоваться одновременная организация домашнего ухода, транспорта, лекарственной терапии, жилищной поддержки и контакта с родственниками. Социальный работник не заменяет врача или юриста, а обеспечивает связность помощи и учет психосоциальных условий.

Межсекторное взаимодействие особенно заметно в общественном здравоохранении. Исследование Б. Рут и Дж. Маршалла показывает, что социальные работники исторически участвовали в профилактике, санитарном просвещении, поддержке материнства и детства, борьбе с инфекционными заболеваниями и организации медицинской помощи [12]. Современная деятельность продолжает эту традицию через работу с социальными детерминантами здоровья. Жилье, питание, безопасность, транспорт и социальная изоляция рассматриваются как факторы, влияющие на выполнение медицинских рекомендаций и восстановление.

Децентрализация предоставляет сообществам возможность приспосабливать услуги к местным потребностям. Однако доступность помощи становится неравной из-за различий налоговой базы, числа специалистов, транспортной инфраструктуры и правил приемлемости. Сельские территории могут испытывать дефицит клинических и кризисных служб, а крупные города сталкиваться с перегрузкой систем. Поэтому формальное наличие программы не означает фактической доступности. Оценка должна включать время ожидания, стоимость, язык обслуживания, физическую доступность и доверие к учреждению.

Качество услуг обеспечивается сочетанием лицензирования, аккредитации организаций, договорного мониторинга, профессиональной супервизии и оценки результатов. При этом измеримые показатели не должны вытеснять содержание помощи. Число проведенных встреч характеризует объем деятельности, но само по себе не подтверждает повышение благополучия. Более полная оценка объединяет количественные результаты, опыт клиента, соблюдение прав и устойчивость изменений после завершения программы.

1.3 Профессиональное образование, аккредитация и лицензирование

Профессиональная подготовка социальных работников ведется преимущественно по программам бакалавриата и магистратуры. Степень BSW ориентирует на общую, или генералистскую, практику с индивидами, семьями, группами, организациями и сообществами. Степень MSW углубляет подготовку и позволяет выбрать специализацию, например клиническую практику, администрирование, школьную социальную работу или социальную политику. Докторские программы ориентированы преимущественно на исследования, преподавание и научное лидерство, хотя их содержание различается между университетами.

Качество программ поддерживается аккредитацией Совета по образованию в области социальной работы. Стандарты CSWE 2022 года построены вокруг компетентностной модели. Компетентность понимается не как сумма прослушанных дисциплин, а как способность интегрировать знания, ценности, навыки, когнитивные и аффективные процессы в наблюдаемой профессиональной деятельности [5]. Это требует от программы не только объяснить содержание курса, но и продемонстрировать способы оценки сформированности умений студента.

Таблица 3 — Девять компетенций социального работника по стандартам CSWE

Номер	Содержание компетенции
1	Демонстрировать этичное и профессиональное поведение
2	Содействовать правам человека и социальной, расовой, экономической и экологической справедливости

Таблица 3 — Девять компетенций социального работника по стандартам CSWE

Номер	Содержание компетенции
3	Учитывать антирасистский подход, разнообразие, равенство и инклюзию в практике
4	Использовать исследования, информированные практикой, и практику, информированную исследованиями
5	Участвовать в практике формирования социальной политики
6	Устанавливать взаимодействие с индивидами, семьями, группами, организациями и сообществами
7	Проводить оценку индивидов, семей, групп, организаций и сообществ
8	Осуществлять вмешательство на разных системных уровнях
9	Оценивать практику с индивидами, семьями, группами, организациями и сообществами

Центральным компонентом обучения является полевая практика под руководством квалифицированного специалиста. Студент применяет теорию в реальной организации, ведет документацию, участвует в супервизии и получает обратную связь. Полевое обучение связывает классное образование с профессиональной ответственностью. Оно также позволяет выявить разницу между знанием алгоритма и способностью выстраивать отношения, распознавать неопределенность и принимать решение в условиях ограниченных ресурсов [5; 6].

Лицензирование регулируется штатами, а не единой федеральной лицензией. Ассоциация советов социальной работы разрабатывает экзамены и поддерживает модельные подходы, но каждая юрисдикция устанавливает собственные названия лицензий, требования к стажу, супервизии, продлению и непрерывному образованию. Вследствие этого одинаковые аббревиатуры могут иметь разное содержание, а переезд специалиста требует проверки правил нового штата [3].

В обобщенной модели выделяются бакалаврский, магистерский, продвинутый генералистский и клинический уровни. Клиническая лицензия обычно требует степени MSW, экзамена и определенного периода управляемой постдипломной практики. Именно лицензированный клинический социальный работник может самостоятельно предоставлять психотерапевтические услуги в пределах компетенции и законодательства штата. Наличие степени без необходимой лицензии не следует автоматически отождествлять с правом независимой клинической практики.

Отчет ASWB о лицензированной рабочей силе 2024 года оценивает численность лицензированных социальных работников примерно в 463 тысячи человек. Более 94 процентов респондентов этой профессиональной группы имели степень MSW. Показатель не совпадает с общим числом занятых социальных работников, поскольку охватывает лишь лицензированных специалистов и опирается на особую методику исследования [3]. Различие этих данных с данными Бюро трудовой статистики демонстрирует необходимость учитывать границы статистической категории.

Супервизия выполняет образовательную, поддерживающую и контрольную функции. Она помогает анализировать случай, проверять этические основания, развивать рефлексию и предотвращать профессиональное выгорание. Для начинающего специалиста супервизия не является второстепенной консультацией, а образует механизм защиты клиента и развития компетентности. После получения лицензии профессиональное развитие продолжается через непрерывное образование, консультирование коллег и освоение новых исследований.

Американская модель подготовки отличается сильной связью между университетом, практикой и регулятором. Ее преимуществом является проверяемость компетенций, а ограничением — разнообразие требований штатов и стоимость образования. Кроме того, формальная квалификация не устраняет необходимости культурной рефлексии и участия самих сообществ в оценке качества помощи. Профессиональный стандарт задает минимально допустимую основу, но не исчерпывает мастерство.

2 ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И ЭТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

2.1 Ведущие теоретические подходы

Теоретическая специфика социальной работы США заключается в интеграции знаний о личности, семье, группе, организации, культуре и публичной политике. Практик не ограничивается объяснением поведения внутренними особенностями человека. Подход «человек в среде» предполагает анализ взаимного влияния индивидуальных ресурсов и социальных условий. Одинаковые симптомы могут иметь разное значение в ситуации безопасного жилья и при угрозе выселения, а трудности выполнения медицинского режима могут быть связаны не с мотивацией, а с отсутствием транспорта и дохода.

Системный подход рассматривает клиентскую ситуацию как сеть взаимозависимых элементов. Изменение одного элемента способно повлиять на семью, школу, рабочее место или службу. Экологическая перспектива дополняет это представление понятиями приспособления, ресурсов, стресса и соответствия между потребностями человека и возможностями среды. Вмешательство может быть направлено не только на развитие навыков клиента, но и на устранение организационного барьера, перестройку маршрута услуг или усиление неформальной поддержки [8; 15].

Ориентация на сильные стороны, или ресурсный подход, противостоит редукции человека к диагнозу и дефициту. Специалист выявляет способности, прошлый успешный опыт, ценности, отношения и ресурсы сообщества. Это не означает игнорирования риска или страдания. Оценка безопасности остается обязательной, однако план строится не исключительно на перечне проблем. Человек рассматривается как участник изменений, обладающий знанием о собственной жизни и правом определять значимые цели.

Эмпауэрмент развивает ресурсную перспективу в направлении расширения контроля человека и группы над условиями жизни. На индивидуальном уровне он проявляется в доступе к информации, осознанном выборе и развитии навыков самоадвокации. На уровне сообщества он связан с коллективным представлением интересов, участием в принятии решений и изменением неравного распределения ресурсов. Профессиональная помощь

не должна создавать новую зависимость от эксперта. Поэтому важны прозрачность полномочий специалиста и возможность клиента влиять на процесс [15].

Травма-информированная практика учитывает возможное влияние насилия, утраты, дискриминации и хронической небезопасности. Ее базовыми ориентирами становятся безопасность, предсказуемость, выбор, сотрудничество и предотвращение повторной травматизации. Данный подход применим не только в психотерапии. Обстановка приема, формулировки документов, порядок проверок и способ запроса личной информации также могут усиливать или снижать чувство контроля. Организационные процедуры оцениваются с точки зрения их воздействия на клиента и работника.

Антиопрессивная и культурно отзывчивая практика обращает внимание на расовое, экономическое, гендерное, возрастное и иное неравенство. Культурная компетентность не сводится к запоминанию характеристик групп, поскольку такой путь ведет к стереотипизации. Более надежной является культурная скромность, предполагающая постоянную рефлексию, признание ограниченности собственного знания и уточнение значений у клиента. На организационном уровне анализируется, кто остается вне услуги, какие правила создают непропорциональные препятствия и как представлены сообщества в управлении [5; 7].

Когнитивно-поведенческие, задачно-центрированные, кризисные, психодинамические, нарративные и другие модели используются в соответствии с проблемой, доказательной базой, предпочтениями клиента и квалификацией специалиста. М. Пейн подчеркивает, что теории выполняют объяснительную, ориентирующую и критическую функции, но не должны превращаться в универсальные рецепты [8]. Выбор модели требует обоснования и последующей оценки результата. Эклектичность без ясной логики может сделать вмешательство противоречивым.

Таблица 4 — Практическое значение основных теоретических подходов

Подход	Фокус анализа	Пример вмешательства
Человек в среде	Взаимодействие личных и социальных факторов	Одновременная работа с доходом, жильем, здоровьем и поддержкой
Системный и экологический	Связи, обратные связи и соответствие потребностей ресурсам	Изменение маршрута между службами и укрепление семейной сети
Ориентация на сильные стороны	Способности, достижения и доступные опоры	Построение плана на основе успешного опыта преодоления
Эмпауэрмент	Выбор, участие и контроль над решениями	Обучение самоадвокации и включение клиента в планирование
Травма-информированный	Безопасность, доверие и последствия травматического опыта	Предсказуемая процедура, выбор темпа и предотвращение принуждения
Антиопрессивный	Структурное неравенство и профессиональная власть	Устранение дискриминационного барьера и поддержка коллективной адвокации

Доказательная практика объединяет наилучшие доступные исследования, профессиональный опыт, характеристики ситуации и предпочтения клиента. Она не означает механического применения протокола. Необходимо проверять качество исследования, применимость выборки, возможные побочные последствия и доступность метода. Если убедительных исследований недостаточно, неопределенность признается открыто, а решение сопровождается усиленным мониторингом и консультацией. Так формируется связь между наукой, этикой и повседневной практикой.

2.2 Технология работы с клиентом и сообществом

Технология социальной работы представляет собой циклический процесс, а не жесткую последовательность. В учебнике Д. Хепворта и соавторов выделяются этапы включения, исследования и оценки, планирования, измененческой работы и завершения [6]. В реальной ситуации возможен возврат к предыдущему этапу после появления новых сведений или изменения риска. Документация фиксирует основания решений, согласованные цели, действия участников и результаты, обеспечивая преемственность помощи.

На этапе установления контакта формируются рабочие отношения и разъясняются роли. Специалист сообщает о цели встречи, пределах конфиденциальности, порядке принятия решений и доступных полномочиях. Внимательное слушание, уточнение и признание эмоций снижают неопределенность. При обязательном направлении, например по решению суда, особенно важно не изображать участие как полностью добровольное. Доверие строится на честном объяснении ограничений и на максимально возможном выборе внутри установленных требований.

Оценка объединяет сведения о проблеме, ресурсах, рисках, культуре, отношениях и среде. Используются интервью, наблюдение, анализ документов, стандартизированные инструменты и консультации с другими специалистами. Данные сверяются между источниками, а противоречия не скрываются. Оценка риска самоубийства, насилия, жестокого обращения или отсутствия безопасного жилья имеет приоритет перед долгосрочными целями. Вместе с тем риск не рассматривается как единственная характеристика клиента.

Планирование переводит общее намерение в конкретные, достижимые и проверяемые результаты. Формулировка целей предполагает участие клиента и распределение ответственности. Например, вместо абстрактной задачи улучшения жилищной ситуации определяются подача заявления, сбор документов, проверка доступных вариантов и сроки повторной оценки. Одновременно учитываются препятствия, которые клиент не контролирует. Ответственность за недостаток жилья не может быть переложена на человека через список индивидуальных заданий.

Вмешательство включает консультирование, развитие навыков, кризисную стабилизацию, предоставление информации, посредничество, кейс-менеджмент, групповую работу и адвокацию. На мезоуровне могут создаваться группы взаимопомощи, школьные программы и партнерства организаций. На макроуровне проводятся анализ политики, бюджетная адвокация, организационные изменения и исследования потребностей сообщества. Разделение уровней помогает планированию, но на практике они дополняют друг друга.

Оценка результата осуществляется на протяжении всего процесса. Специалист сопоставляет исходные показатели с текущими, уточняет опыт клиента и анализирует непредусмотренные последствия. При отсутствии изменений пересматриваются не только мотивация и выполнение заданий, но и правильность оценки, качество отношений и доступность ресурсов. Завершение включает обобщение достигнутого, планирование устойчивой поддержки, передачу случая при необходимости и обсуждение действий при повторном кризисе.

Таблица 5 — Обобщенный цикл социальной работы

Этап	Основные действия	Критерий качества
Установление контакта	Разъяснение роли, согласия и пределов конфиденциальности	Понимание клиентом процесса и наличие рабочего сотрудничества
Оценка	Сбор и проверка данных о рисках, ресурсах и среде	Целостность картины и отсутствие необоснованных стереотипов
Планирование	Определение приоритетов, целей, действий и сроков	Участие клиента и реалистичность распределения ответственности
Вмешательство	Консультирование, ресурсная связь, групповая работа, адвокация	Обоснованность метода и соблюдение компетенции

Таблица 5 — Обобщенный цикл социальной работы

Этап	Основные действия	Критерий качества
Оценка результата	Мониторинг изменений, опыта клиента и побочных последствий	Использование нескольких источников сведений
Завершение	Закрепление изменений, план поддержки и передача случая	Преемственность и понятный порядок повторного обращения

Работа с сообществом начинается с совместного определения проблемы и картирования ресурсов. Важно включать не только руководителей учреждений, но и жителей, непосредственно затронутых решением. Их участие не должно быть символическим приглашением после подготовки готового проекта. Сообщество вовлекается в постановку приоритетов, распределение полномочий и оценку. Такой процесс требует больше времени, однако снижает риск создания услуги, которая формально соответствует гранту, но не отвечает повседневным потребностям.

Документирование выполняет профессиональную и правовую функции. Записи должны быть точными, своевременными, необходимыми для помощи и защищенными от несанкционированного доступа. Оценочные суждения отделяются от наблюдаемых фактов, а стигматизирующие характеристики исключаются. Клиент имеет предусмотренные законом права доступа к информации. Цифровые системы повышают возможности обмена данными, но требуют минимизации собираемых сведений и ясных соглашений между организациями.

2.3 Этические принципы и принятие решений

Кодекс этики NASW задает миссию профессии и шесть основных ценностей: служение, социальную справедливость, достоинство и ценность человека, значимость человеческих отношений, честность и компетентность [7]. Кодекс распространяется на ответственность перед клиентами, коллегами, в месте работы, перед самой профессией и обществом. Он ориентирует поведение, но не предоставляет автоматического ответа для каждой сложной ситуации. Этическая зрелость проявляется в обоснованном разрешении столкновения обязанностей.

Самоопределение клиента связано с правом участвовать в выборе целей и методов. Оно может ограничиваться законом и серьезным, предсказуемым риском для жизни и безопасности. Ограничение требует объяснения, документирования и применения наименее ограничительной меры, допустимой в конкретной правовой системе. Профессиональная забота не должна подменяться контролем ради удобства учреждения. Даже при обязательном вмешательстве сохраняются уважение, доступная информация и пространство выбора.

Информированное согласие предполагает понятное описание услуги, возможных рисков, альтернатив, стоимости, использования записей и права отозвать согласие. Способность человека понимать информацию оценивается без стереотипов о возрасте, инвалидности или диагнозе. При необходимости применяются перевод, доступные форматы и поддержка коммуникации. Подпись на форме не заменяет реального понимания, особенно при дистанционных услугах и сложных межведомственных маршрутах.

Конфиденциальность укрепляет доверие, однако не является абсолютной. Исключения связаны с требованиями закона, защитой от серьезного вреда, судебными процедурами и согласованным обменом информацией. Пределы разъясняются заранее. Раскрывается только необходимый объем сведений, а обращение с данными в электронных системах сопровождается мерами безопасности. Ф. Ример подчеркивает, что современные этические проблемы охватывают не только отдельные поступки, но и цифровую коммуникацию, границы отношений, управление рисками и ответственность организаций [9].

Таблица 6 — Ценности NASW и их практическое выражение

Ценность	Практическое выражение
Служение	Приоритет потребностей людей и доступности помощи
Социальная справедливость	Выявление дискриминации и участие в изменении несправедливых правил
Достоинство и ценность человека	Уважительное отношение независимо от статуса, диагноза и поведения
Значимость человеческих отношений	Партнерство, поддержка связей и признание роли сообщества
Честность	Достоверное представление квалификации, ограничений и результатов
Компетентность	Работа в пределах подготовки, супервизия и постоянное развитие

Дуальные отношения возникают при совмещении профессиональной и иной роли. В малом сообществе полностью избежать пересечений не всегда возможно, поэтому оцениваются риск эксплуатации, конфликт интересов и влияние на объективность. Профессиональные границы поддерживаются через прозрачные договоренности, супервизию и документирование. Особую опасность представляют сексуальные отношения с клиентами, финансовая эксплуатация и использование доверия в личных интересах.

Обобщенный алгоритм этического решения включает определение участников и обязанностей, проверку фактов, анализ Кодекса и закона, рассмотрение альтернатив, оценку последствий, консультацию, выбор наименее вредного варианта и последующую рефлексию. Культурный контекст и неравенство власти учитываются на каждом этапе. Решение не должно основываться только на личной интуиции или только на инструкции. Супервизия снижает риск изолированного выбора, но не снимает профессиональную ответственность.

В редакцию Кодекса 2021 года усилено значение профессиональной заботы о себе. Перегрузка, вторичная травматизация и выгорание могут ухудшать суждение и качество отношений. Ответственность распределяется между специалистом и организацией. Индивидуальные практики восстановления не компенсируют небезопасную нагрузку, отсутствие персонала и неподдерживающее управление. Организациям рекомендуется создавать условия для супервизии, отдыха, обучения и обращения за помощью без стигматизации [7].

3 ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАКТИКИ

3.1 Социальная работа с детьми, семьями и в школе

Работа с детьми и семьями включает профилактику неблагополучия, поддержку родительства, кризисное вмешательство, защиту от жестокого обращения, приемное воспитание, усыновление и воссоединение семьи. Службы защиты детей реагируют на сообщения о риске, проводят расследование или альтернативную оценку и определяют необходимость услуг. Федеральное законодательство задает общие ориентиры, но определения, процедуры и организационные структуры различаются по штатам. Поэтому американская система child welfare представляет собой совокупность связанных, но неодинаковых юрисдикционных моделей.

По отчету Child Maltreatment 2023, в федеральном финансовом году 2023 52 юрисдикции, предоставившие данные, зафиксировали 546159 детей, признанных пострадавшими от жестокого обращения или неглигенции. Это соответствовало 7,4 ребенка на тысячу детей населения. Примерно 64,1 процента пострадавших испытали только пренебрежение нуждами, или неглигенцию [2]. Показатели отражают случаи, известные системе защиты, а не полную распространенность насилия в обществе. На них влияют доступность сообщения, правила отбора обращений и методы расследования.

Преобладание пренебрежения нуждами показывает тесную связь защиты детей с бедностью, жилищной нестабильностью, психическим здоровьем, зависимостями и доступом к базовым ресурсам. Материальная нужда не отождествляется с жестоким обращением, но повышает нагрузку на семью и вероятность контакта со службами. Практическая задача состоит в сочетании защиты ребенка с устранением условий риска. Жилищная помощь, питание, доступное медицинское обслуживание и поддержка ухода могут быть такими же значимыми элементами безопасности, как надзор и консультирование.

Семейно-ориентированная практика предполагает оценку риска и ресурсов всех участников. При безопасных условиях приоритетом становится сохранение ребенка в семье или родственной сети, устойчивая поддержка опекунов и минимизация травматичных перемещений. Решения о разлучении относятся к наиболее ответственным и требуют правовых оснований,

проверки менее ограничительных альтернатив и внимания к культурным связям ребенка. Участие детей в обсуждении реализуется с учетом возраста, развития и безопасности.

Школьные социальные работники связывают семью, образовательную команду и внешние службы. Они работают с пропусками занятий, поведенческими трудностями, кризисами, издевательствами, жилищной нестабильностью и включением детей с особыми потребностями. Их роль не исчерпывается индивидуальным консультированием. Анализ школьного климата, консультирование персонала, групповые программы и адвокация позволяют устранять системные барьеры обучения. Оценка учитывает, как правила дисциплины и доступность поддержки влияют на разные группы учащихся.

Профилактика включает домашнее посещение, поддержку родителей, раннее выявление задержек развития, финансовую и жилищную стабилизацию, программы здоровья и развитие добровольческих сетей. Эффективность профилактики повышается при добровольном и уважительном участии семьи. Если обращение за помощью автоматически воспринимается как угроза расследования, доверие снижается. Разграничение профилактических и контрольных функций, понятная информация о правах и доступ к услугам до кризиса образуют важное направление развития системы.

3.2 Медицинская, клиническая и кризисная социальная работа

В больницах, амбулаторных центрах, хосписах и реабилитационных учреждениях социальные работники оценивают психосоциальные факторы, поддерживают пациента и семью, содействуют планированию выписки и связывают лечение с ресурсами сообщества. Медицинский диагноз рассматривается в контексте жилища, дохода, ухода, культуры и отношений. Такой подход снижает вероятность того, что формально правильный план лечения окажется невыполнимым из-за социальных обстоятельств [12].

В паллиативной помощи специалист поддерживает обсуждение ценностей, принятие решений, семейную коммуникацию, скорбь и практическую организацию ухода. В реабилитации значимы адаптация к изменившимся возможностям, доступная среда и участие в общественной

жизни. В обоих направлениях социальная работа выходит за рамки решения материальных вопросов. Она создает пространство для субъективного опыта болезни и помогает команде видеть пациента не только как носителя клинического состояния.

Клинические социальные работники проводят психосоциальную оценку, психотерапию, кризисное вмешательство и координацию помощи при психических расстройствах и зависимостях. Независимая клиническая практика требует соответствующей лицензии и соблюдения компетенции. Социальная идентичность клинициста сохраняет ориентацию на среду даже при использовании психотерапевтического метода. Симптомы изучаются наряду с дискриминацией, экономической небезопасностью, насилием и доступностью непрерывного лечения.

Кризисная система включает телефонную поддержку, мобильные бригады, кратковременную стабилизацию, неотложную медицинскую помощь и последующее сопровождение. В 2022 году в США начала работать общенациональная линия 988 для суицидальных и психических кризисов. Национальные рекомендации SAMHSA для детей и молодежи обобщают модель через три взаимосвязанных компонента: наличие контакта для обращения, наличие мобильной реакции и наличие безопасного места стабилизации [13]. Сама линия не заменяет развитую сеть последующих услуг.

При кризисе приоритетом становятся безопасность, деэскалация, оценка непосредственного риска и совместный план ближайших действий. Принуждение и госпитализация не рассматриваются как универсальный ответ, а применяются по правовым основаниям при необходимости. Возможности домашней и общинной стабилизации, участие семьи и поддержка равных консультантов позволяют расширить альтернативы. Для детей необходимы возрастная коммуникация, учет развития и защита от повторной травматизации [13].

В работе с зависимостями соединяются мотивационное консультирование, лечение, снижение вреда, восстановление, семейная поддержка и устранение социальных барьеров. Стигматизация способна скрывать проблему и ограничивать обращение за медицинской помощью. Поэтому воздержание от осуждающих формулировок является не внешней

вежливостью, а условием эффективности. Оценка результата включает безопасность, качество жизни, здоровье и устойчивость поддержки, а не только отдельный показатель употребления.

3.3 Жилищная поддержка, старение, инвалидность и защита уязвимых групп

Социальная работа с бездомностью включает уличную выездную практику, экстренное размещение, профилактику выселения, быстрое повторное расселение, постоянное поддерживаемое жилье и сопровождение после получения жилья. Подход Housing First исходит из приоритета постоянного жилья без предварительного требования решить все проблемы человека. Медицинская, психологическая и трудовая поддержка предлагается в связке с жилищной стабильностью. Выбор услуг и сохранение жилья требуют продолжительного кейс-менеджмента.

По единовременному январскому подсчету 2024 года HUD зарегистрировал 771480 человек, испытывавших бездомность в США. Из них 497256 находились в приютах, транзитном жилье или безопасных гаванях, а 274224 — в местах, не предназначенных для проживания [14]. Подсчет представляет ситуацию одной ночи и не равен годовому числу людей, столкнувшихся с бездомностью. Он также зависит от охвата и условий наблюдения. Статистика подтверждает масштаб потребности, но не объясняет причины без анализа рынка жилья, доходов и систем поддержки.

Профилактика бездомности может быть более гуманной и экономически рациональной, чем реагирование после утраты жилья. Она включает юридическую защиту от незаконного выселения, краткосрочную арендную поддержку, разрешение конфликтов и адресацию людей, покидающих стационар, тюрьму или приемную систему. Межведомственные разрывы особенно опасны в таких переходах. Социальный работник координирует сроки и документы, но устойчивый результат зависит также от наличия доступного жилого фонда.

Работа с пожилыми людьми направлена на поддержание самостоятельности, предотвращение изоляции, защиту от насилия и эксплуатации, организацию долгосрочного ухода и поддержку ухаживающих родственников. Возраст сам по себе не рассматривается как неспособность

принимать решения. Специалист применяет доступную коммуникацию и поддерживает максимальное участие человека. При когнитивных нарушениях оцениваются конкретные способности и правовые основания представительства, а не делается общий вывод по диагнозу.

Социальная работа с людьми с инвалидностью опирается на права, доступность и независимую жизнь. Медицинская модель, сосредоточенная на дефекте, дополняется социальной моделью, которая выявляет барьеры архитектуры, транспорта, информации и отношения. Персональная помощь, ассистивные технологии, разумные приспособления на работе и поддерживаемое принятие решений расширяют самостоятельность. Клиент участвует в определении желаемого образа жизни, а организация услуг подстраивается под него, а не наоборот.

С мигрантами и беженцами практика включает языковой доступ, правовую навигацию, восстановление семейных связей, поддержку после травмы и включение в сообщество. Специалист разграничивает собственные полномочия и юридическую консультацию, при необходимости направляя к квалифицированному правозащитнику. Незнание миграционного статуса не должно превращаться в предположение о поведении человека. Безопасность данных и доверие особенно значимы при страхе перед государственными учреждениями.

В системе уголовного правосудия социальные работники участвуют в оценке потребностей, программах отвода от суда, восстановительных практиках, поддержке после освобождения и работе с пострадавшими. Центральная этическая трудность состоит в совмещении помощи и функций контроля. Честное разъяснение назначения информации и пределов конфиденциальности уменьшает риск скрытого принуждения. На макроуровне анализируются социальные причины вовлечения в систему и непропорциональное воздействие наказаний на отдельные группы.

Таблица 7 — Сферы практики и приоритеты социального работника

Сфера	Приоритетные задачи	Необходимое партнерство
Дети и семьи	Безопасность, профилактика, поддержка ухода и семейных связей	Школа, здравоохранение, жилищные и юридические службы
Здравоохранение	Психосоциальная оценка, выписка, доступность лечения	Медицинская команда, страховые и общинные ресурсы
Психическое здоровье	Кризисная безопасность, терапия, восстановление	Кризисные службы, психиатрия, равные консультанты
Бездомность	Профилактика выселения, жилье и устойчивое сопровождение	Жилищные организации, арендодатели, юристы
Пожилые и люди с инвалидностью	Самостоятельность, доступность, защита и поддержка ухода	Службы долгосрочного ухода, транспорт, общественные организации
Миграция и правосудие	Права, безопасность, социальная интеграция и восстановление	Правозащитники, переводчики, общинные и исправительные службы

3.4 Занятость, цифровизация и перспективы развития

Профессиональная занятость охватывает детские, семейные и школьные службы, здравоохранение, психическое здоровье и зависимости, а также другие направления. По данным Бюро трудовой статистики США, в 2024 году насчитывалось 810900 рабочих мест социальных работников. Медианная годовая оплата в мае 2024 года составляла 61330 долларов. Прогноз на 2024–2034 годы предполагает рост занятости на 6 процентов, что превышает средний темп по всем профессиям в используемой классификации [4].

Медианная оплата различалась по направлениям. В здравоохранении она составляла 68090 долларов, среди специалистов по психическому здоровью и зависимостям — 60060 долларов, среди детских, семейных и школьных социальных работников — 58570 долларов. Категория «все прочие социальные работники» имела показатель 69480 долларов [4]. Медиана не является гарантированной заработной платой и не учитывает различия штатов, стоимости жизни, лицензии, опыта и формы занятости.

Таблица 8 — Показатели профессии по данным Бюро трудовой статистики США

Показатель	Значение	Год или период
Число рабочих мест	810900	2024
Медианная годовая оплата всех социальных работников	61330 долларов	Май 2024
Медианная оплата в здравоохранении	68090 долларов	Май 2024
Медианная оплата в сфере психического здоровья и зависимостей	60060 долларов	Май 2024
Медианная оплата детских, семейных и школьных специалистов	58570 долларов	Май 2024
Прогнозируемый рост занятости	6 процентов	2024–2034

Спрос на специалистов связан со старением населения, потребностями поведенческого здоровья, хроническими заболеваниями и координацией социальных детерминантов здоровья. Одновременно система сталкивается с высокой нагрузкой, текучестью кадров и неравномерным размещением работников. Прогноз роста рабочих мест не гарантирует достаточного числа сотрудников в конкретной сельской местности или перегруженной службе. Качество помощи зависит от размера случайной нагрузки, супервизии, оплаты и организационной безопасности.

Цифровизация проявляется в телемедицине, видеоконсультировании, электронных записях, онлайн-записи, дистанционной супервизии и аналитике данных. Дистанционный формат способен сократить транспортные барьеры и повысить непрерывность помощи. Однако он требует проверки местоположения клиента, применимой лицензии, конфиденциального пространства, защищенной связи и плана действий при кризисе. Отсутствие устройства, устойчивого интернета или цифровых навыков может закрепить неравенство.

Социальные сети и поисковые системы создают дополнительные вопросы границ. Необходимо разграничивать профессиональную и личную коммуникацию, избегать публикации идентифицирующих сведений и не собирать информацию о клиенте без профессионального основания. Автоматизированные системы оценки риска требуют особой осторожности. Алгоритм способен воспроизводить историческую дискриминацию, а его вывод не должен заменять клиническое и социальное суждение. Прозрачность, проверка ошибок и возможность человеческого пересмотра являются условиями ответственного использования.

Развитие профессии связано с усилением интегрированной помощи. Совместное размещение социальных работников в медицинских, школьных и жилищных службах уменьшает разрывы между секторами. Равные консультанты с собственным опытом бездомности, зависимости или психического кризиса дополняют профессиональную работу и повышают доверие. Их участие требует оплачиваемых ролей, ясных границ и реального влияния на проектирование услуг, а не символического присутствия.

Другое направление — переход от исключительно кризисного реагирования к профилактике и устранению структурных причин. Жилищная

доступность, доход, транспорт, образование и безопасная среда определяют результат не меньше, чем качество отдельной консультации. Это не уменьшает значение прямой практики, а требует соединения микро- и макроуровней. Адвокация становится профессиональной обязанностью, когда правила систематически препятствуют благополучию клиентов [7; 10].

Перспективы американской социальной работы зависят от способности сохранять баланс между технологией и отношениями, подотчетностью и профессиональным суждением, клинической специализацией и социальными изменениями. Наиболее устойчивой представляется модель, в которой клиент и сообщество участвуют в решениях, работник получает поддержку, а оценка результатов учитывает права и качество жизни. Такой баланс позволяет использовать достижения стандартизации без превращения помощи в формальную процедуру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ показывает, что социальная работа в США сформировалась на пересечении благотворительности, общественных реформ, университетского образования и развития государства всеобщего благосостояния. Движение обществ организации благотворительности способствовало систематизации индивидуального обследования, а движение поселений укрепило ориентацию на среду, сообщество и социальную справедливость. Работы Мэри Ричмонд и Джейн Аддамс отражают два взаимодополняющих измерения профессии. Их историческое противопоставление не должно скрывать общую задачу повышения человеческого благополучия.

Современная система отличается многоуровневостью и плюрализмом поставщиков. Федеральные органы, штаты, местные администрации, некоммерческие и частные организации выполняют различные функции. Такая организация поддерживает локальную гибкость и многообразие услуг, но создает неравенство доступа и сложность навигации. Кейс-менеджмент и межсекторное партнерство частично компенсируют фрагментацию, однако не устраняют дефицит жилья, кадров и финансирования. Эффективность системы оценивается не только наличием программ, но и реальной возможностью своевременно получить помощь.

Профессиональное образование основано на аккредитованных программах BSW и MSW, полевой практике, компетентностных стандартах CSWE и последующем лицензировании. Девять компетенций интегрируют этику, права человека, разнообразие, исследования, политику, взаимодействие, оценку, вмешательство и оценивание практики. Лицензирование штатами повышает защиту потребителей и определяет границы самостоятельной деятельности, хотя разнообразие требований ограничивает профессиональную мобильность. Супервизия и непрерывное образование поддерживают качество после завершения формального обучения.

Теоретической основой практики является подход «человек в среде». Системная и экологическая перспективы, ресурсный подход, эмпауэрмент, травма-информированная и антиопрессивная практика позволяют

анализировать личную ситуацию вместе с социальными условиями. Технология помощи включает установление контакта, оценку, планирование, вмешательство, оценку результата и завершение. Цикличность процесса и участие клиента препятствуют механическому применению алгоритма. Доказательная практика соединяет исследования, опыт, предпочтения человека и профессиональную рефлексию.

Кодекс этики NASW закрепляет служение, справедливость, достоинство, значимость отношений, честность и компетентность. Самоопределение, информированное согласие и конфиденциальность требуют постоянного согласования с безопасностью и законом. Этическое решение не сводится к выбору готовой нормы. Оно предполагает проверку фактов, анализ власти, консультацию, сравнение последствий и документирование. Забота о себе и ответственность организации за условия труда рассматриваются как элемент качества помощи.

Анализ отдельных сфер подтверждает взаимосвязь социальных проблем. Защита детей связана с бедностью и жильем, медицинское восстановление — с транспортом и поддержкой, психическое здоровье — с доступностью непрерывной помощи, а бездомность — с рынком жилья и переходами между институтами. Официальные показатели выявляют масштаб вызовов, но требуют методологически осторожного толкования. Данные о зарегистрированных случаях или единовременных подсчетах не исчерпывают реальной распространенности явлений.

Кадровые данные Бюро трудовой статистики указывают на значительный размер профессии и ожидаемый рост занятости. Вместе с тем численный рост не решает проблемы выгорания, регионального дефицита и неравной оплаты. Цифровизация расширяет доступ, но требует защиты данных, соблюдения лицензионных границ и преодоления цифрового неравенства. Алгоритмические инструменты должны оставаться подчиненными профессиональной оценке и правам человека.

Цель работы достигнута, поскольку рассмотрены история, организация, подготовка, теория, технология, этика и основные сферы социальной работы США. Американский опыт демонстрирует значение единых образовательных компетенций, лицензирования, супервизии, межсекторного кейс-менеджмента и участия клиентов. Его критическое использование

предполагает учет национального законодательства и ресурсов. Наиболее перспективным является не копирование отдельных институтов, а адаптация принципа целостной помощи, соединяющей личные изменения, доступную среду и социальную справедливость.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Addams J. Twenty Years at Hull-House. New York: Macmillan, 1910

2. Administration for Children and Families. Child Maltreatment 2023. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2025. URL: https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/cb/cm2023.pdf (дата обращения: 06.11.2026)

3. Association of Social Work Boards. The Licensed Social Work Workforce: 2024 Social Work Workforce Study. Culpeper, VA: ASWB, 2025. URL: https://www.aswb.org/wp-content/uploads/2025/07/Social-Work-Workforce-Study-Series-Report-2.pdf (дата обращения: 06.11.2026)

4. Bureau of Labor Statistics. Social Workers // Occupational Outlook Handbook. U.S. Department of Labor, 2025. URL: https://www.bls.gov/ooh/community-and-social-service/social-workers.htm (дата обращения: 06.11.2026)

5. Council on Social Work Education. Educational Policy and Accreditation Standards for Baccalaureate and Master's Social Work Programs. Alexandria, VA: CSWE, 2022. URL: https://www.cswe.org/sites/default/files/2026-07/2022_EPAS.pdf (дата обращения: 06.11.2026)

6. Hepworth D. H., Vang P. D., Blakey J. M., Schwalbe C., Evans C. B. R., Rooney R. H., Rooney G. D., Strom K. Direct Social Work Practice: Theory and Skills. 10th ed. Boston: Cengage Learning, 2017

7. National Association of Social Workers. Code of Ethics of the National Association of Social Workers. Washington, DC: NASW, 2021. URL: https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English (дата обращения: 06.11.2026)

8. Payne M. Modern Social Work Theory. 5th ed. London: Red Globe Press, 2020

9. Reamer F. G. Social Work Values and Ethics. 5th ed. New York: Columbia University Press, 2018

10. Reisch M. Lessons from Social Work's History for a Tumultuous Era // Social Service Review. 2019. Vol. 93, No. 4. P. 581–607. DOI: 10.1086/706741

11. Richmond M. E. Social Diagnosis. New York: Russell Sage Foundation, 1917

12. Ruth B. J., Marshall J. W. A History of Social Work in Public Health // American Journal of Public Health. 2017. Vol. 107, Suppl. 3. P. S236–S242. DOI: 10.2105/AJPH.2017.304005

13. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. National Guidelines for Child and Youth Behavioral Health Crisis Care. Publication No. PEP22-01-02-001. Rockville, MD: SAMHSA, 2022. URL: https://library.samhsa.gov/product/national-guidelines-child-and-youth-behavioral-health-crisis-care/pep22-01-02-001 (дата обращения: 06.11.2026)

14. U.S. Department of Housing and Urban Development. The 2024 Annual Homelessness Assessment Report to Congress. Part 1: Point-in-Time Estimates of Homelessness. Washington, DC: HUD, 2024. URL: https://www.huduser.gov/portal/sites/default/files/pdf/2024-AHAR-Part-1.pdf (дата обращения: 06.11.2026)

15. Zastrow C., Hessenauer S. L. Empowerment Series: Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People. 13th ed. Boston: Cengage, 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Глоссарий основных понятий американской социальной работы

Таблица 9 — Английские термины и их содержание

Термин	Русский эквивалент	Содержание
Social work	Социальная работа	Профессия, направленная на благополучие, ресурсы, права и социальные изменения
Person-in-environment	Человек в среде	Одновременный анализ личности и социальных условий
Generalist practice	Генералистская практика	Работа с разными системами на основе общего набора компетенций
Case management	Кейс-менеджмент	Оценка, планирование, связь ресурсов, координация и мониторинг
Advocacy	Адвокация	Представление интересов и содействие изменению несправедливых правил
Empowerment	Эмпауэрмент	Расширение выбора, участия и контроля человека или сообщества
Supervision	Супервизия	Профессиональное руководство, обучение, поддержка и контроль качества
Field education	Полевое образование	Практическая подготовка студента в профессиональной организации

Таблица 9 — Английские термины и их содержание

Термин	Русский эквивалент	Содержание
Licensure	Лицензирование	Правовое допущение к практике по правилам конкретной юрисдикции
Self-determination	Самоопределение	Право клиента участвовать в выборе целей и решений
Confidentiality	Конфиденциальность	Защита сведений с учетом согласия и установленных законом исключений
Evidence-based practice	Доказательная практика	Интеграция исследований, опыта, ситуации и предпочтений клиента
Trauma-informed care	Травма-информированная помощь	Безопасная практика, учитывающая последствия травмы и риск повторной травматизации
Housing First	Сначала жилье	Приоритет постоянного жилья в сочетании с добровольной поддержкой
Continuum of care	Непрерывность помощи	Связанная система профилактики, кризисной реакции и последующей поддержки

Глоссарий раскрывает наиболее употребимые термины и не заменяет официальные определения законодательства штата. Практическое значение термина проверяется в конкретной программе и нормативном контексте.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обобщенный алгоритм оказания социальной помощи

Алгоритм представляет собой ориентир для генералистской практики. Он не заменяет клинические протоколы, законодательные требования и локальные процедуры. При непосредственной угрозе жизни или безопасности первоочередными являются экстренная оценка и обращение к соответствующим службам.

Таблица 10 — Последовательность действий и документируемые результаты

Шаг	Действие специалиста	Документируемый результат
1	Установить контакт и разъяснить роль, согласие и пределы конфиденциальности	Сведения об обращении, роли и полученном согласии
2	Определить непосредственные риски и необходимость экстренной реакции	Оценка безопасности и принятые защитные меры
3	Собрать сведения о потребностях, ресурсах, культуре и среде	Психосоциальная оценка с разделением фактов и суждений
4	Совместно определить приоритеты и измеримые цели	Согласованный план с распределением ответственности
5	Подобрать обоснованные методы и доступные ресурсы	Обоснование вмешательства и направления к партнерам
6	Реализовать помощь, координируя участников и сохраняя выбор клиента	Записи о действиях, участии и изменениях ситуации
7	Оценивать результат, побочные последствия и опыт клиента	Промежуточные показатели и корректировки плана

Таблица 10 — Последовательность действий и документируемые результаты

Шаг	Действие специалиста	Документируемый результат
8	Завершить или передать случай с планом устойчивой поддержки	Итоговая оценка, рекомендации и порядок повторного обращения

При этической неопределенности дополнительно анализируются нормы NASW, законодательство, права участников и возможные последствия альтернатив. Консультация и супервизия фиксируются в той степени, которая соответствует правилам организации и защите конфиденциальности. Возврат к более раннему шагу допускается при изменении риска, появлении новых данных или пересмотре целей клиентом.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Сопоставление уровней профессиональной подготовки

Таблица 11 — Образование и профессиональные полномочия

Уровень	Типовая подготовка	Общий ориентир практики
BSW	Аккредитованный бакалавриат социальной работы и полевая практика	Генералистская помощь, кейс-менеджмент, работа с ресурсами и сообществами
MSW	Аккредитованная магистратура с общей и специализированной подготовкой	Углубленная прямая, клиническая, административная или политическая практика
Advanced Generalist	Степень MSW и установленный штатом опыт после получения степени	Продвинутая неклиническая практика в юрисдикциях, предусматривающих эту категорию
Clinical	Степень MSW, экзамен и регулируемая постдипломная клиническая супервизия	Самостоятельная клиническая практика в границах лицензии и компетенции
DSW или PhD	Докторская программа с исследовательской или практико-ориентированной направленностью	Исследования, преподавание, руководство и развитие профессионального знания

Таблица представляет обобщенную модель. Названия лицензий, полномочия, стаж и требования супервизии устанавливаются регулятором штата [3]. Для проверки используется действующая информация соответствующего совета.